

ОХОРОНА ПРАЦІ

					Дипломна робота	Арк.
Зміни	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Надавання долікарської допомоги при нещасних випадках

Надання першої домедичної допомоги на підприємствах та в організаціях України регулюється сукупністю нормативно-правових актів, що визначають обов'язки як роботодавця, так і працівників. Відповідно до статті 18 Закону України «Про охорону праці», працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи повинні проходити за рахунок роботодавця навчання та перевірку знань з питань охорони праці, зокрема й з навичок надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків. Крім того, стаття 153 Кодексу законів про працю України покладає на власника підприємства обов'язок щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці. У юридичній площині важливо розрізняти «першу допомогу» та «медичну допомогу». Перша здійснюється особами без спеціальної освіти з метою стабілізації стану, тоді як друга є прерогативою ліцензованих фахівців.

Кримінальний кодекс України також містить положення, що стосуються ненадання допомоги. Стаття 136 ККУ передбачає відповідальність за ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, якщо така допомога могла бути надана без ризику для рятівника. Для працівників, на яких обов'язок надання допомоги покладено інструкціями з охорони праці, це є не лише моральним, а й прямим юридичним зобов'язанням. Таким чином, правове поле України вимагає від кожного члена трудового колективу бути готовим до екстрених дій. Загальна послідовність надання допомоги починається з оцінки ризиків для рятівника. Згідно з протоколами, затвердженими наказами МОЗ України, першочерговим завданням є припинення дії небезпечного фактора: відключення електроенергії, перекриття газу або виведення потерпілого із зони задимлення.

Після забезпечення безпеки необхідно провести первинний огляд для виявлення ознак життя, таких як наявність дихання та свідомості. Виклик екстреної медичної допомоги за номером 103 є обов'язковим і повинен супроводжуватися чітким описом ситуації, що дозволяє диспетчеру правильно

					<i>Дипломна робота</i>	Арк.
Зміни	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

класифікувати виклик. Важливо розуміти, що правильна фіксація часу та обставин події на цьому етапі допоможе в подальшому розслідуванні нещасного випадку спеціальною комісією. Своєчасна оцінка тяжкості травмування дозволяє обрати правильну тактику допомоги, що є критичним при масивних пораненнях, де кожна секунда впливає на виживання. Саме тому наступним кроком є вивчення методів зупинки найбільш небезпечних видів кровотеч, які можуть стати причиною смерті ще до приїзду фахівців.

Зупинка кровотечі є одним із найвідповідальніших етапів надання домедичної допомоги, оскільки масивна втрата крові призводить до незворотних змін в органах і тканинах. В українській практиці навчання працівників базується на стандартах, що розподіляють кровотечі на артеріальні, венозні та капілярні. Найбільш небезпечною є артеріальна кровотеча, ознакою якої є пульсуючий викид крові яскраво-червоного кольору. Згідно з сучасними рекомендаціями, при таких пораненнях кінцівок єдиним ефективним методом є негайне накладання джгута або механічного турнікета. Джгут накладається на 5-8 сантиметрів вище місця поранення, але не на суглоб. Обов'язковою умовою є зазначення часу накладання, оскільки тривале стискання тканин може призвести до їх некрозу.

Венозна кровотеча, яка характеризується безперервним витіканням темної крові, зазвичай зупиняється за допомогою тугої стискальної пов'язки. Для цього на рану накладається стерильна серветка, зверху — щільний валик з бинта або тканини, що міцно прибинтовується до кінцівки. При наданні допомоги заборонено витягувати сторонні предмети з рани, оскільки вони можуть виконувати роль своєрідного корка, а їх вилучення спровокує масивну кровотечу. Натомість такі об'єкти слід фіксувати у нерухомому стані за допомогою пов'язок. Належна обробка країв рани антисептичними засобами (крім потрапляння речовини безпосередньо у рану) дозволяє мінімізувати ризик інфікування та подальших ускладнень.

					Дипломна робота	Арк.
Зміни	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Особливу увагу слід приділяти стану шоку, який часто супроводжує велику крововтрату. Потерпілого необхідно зігріти, вкривши термоковдрою або теплим одягом, та забезпечити йому спокій. Якщо поранення супроводжується внутрішньою кровотечею (ознаками якої є різка блідість, слабкий пульс та холодний піт), єдиною дієвою допомогою є надання тілу горизонтального положення з піднятими ногами та прикладання холоду до ймовірного місця травми. Після стабілізації зовнішньої кровотечі рятівник повинен залишатися поруч із потерпілим, оскільки різка зміна стану може вимагати переходу до реанімаційних заходів, що є наступною ланкою в ланцюгу порятунку життя.

Серцево-легенева реанімація (СЛР) є критичною ланкою в ланцюгу виживання потерпілого при раптовій зупинці серця або припиненні дихання внаслідок нещасного випадку. Згідно з протоколами Міністерства охорони здоров'я України, які базуються на рекомендаціях Європейської ради реанімації, успішність відновлення життєдіяльності прямо залежить від часу початку маніпуляцій. Якщо реанімаційні заходи розпочато у перші дві хвилини після зупинки кровообігу, шанси на виживання та повноцінне відновлення функцій головного мозку зростають у декілька разів. Перед початком процедури необхідно переконатися у відсутності ознак життя: відсутності свідомості (потерпілий не реагує на звернення та фізичний вплив) та відсутності нормального дихання (немає характерних рухів грудної клітки та звуків видиху протягом десяти секунд).

Алгоритм проведення СЛР передбачає виконання непрямого масажу серця та штучної вентиляції легень. Потерпілий повинен перебувати на твердій, рівній поверхні, оскільки проведення компресій на м'якому ліжку чи сидінні є неефективним через амортизацію тіла. Рятувальник розташовує основу долоні на середині грудної клітки (нижня третина грудини), іншу долоню кладе зверху, зчепивши пальці в замок. Руки мають бути прямими в ліктях, а натискання здійснюватися за рахунок ваги власного тулуба, а не лише м'язів рук. Глибина натискань для дорослої людини має становити п'ять-шість сантиметрів, а темп

					Дипломна робота	Арк.
Зміни	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

— від ста до ста двадцяти натискань на хвилину. Після кожної компресії необхідно дозволити грудній клітці повністю розправитися, не відриваючи рук від тіла потерпілого, щоб забезпечити наповнення серця кров'ю.

Співвідношення натискань до вдихів становить тридцять до двох. Перед проведенням штучного дихання необхідно забезпечити прохідність дихальних шляхів методом закидання голови назад та підняття підборіддя. Штучний вдих виконується методом «рот-до-рота» або «рот-до-носа» з обов'язковим використанням бар'єрних засобів, таких як маска-клапан з аптечки, для захисту рятувальника від інфекцій. Вдих має тривати близько однієї секунди та супроводжуватися видимим підняттям грудної клітки потерпілого. Якщо рятувальник з будь-яких причин не може або не бажає виконувати штучне дихання, міжнародні стандарти допускають проведення лише неперервних компресій грудної клітки до приїзду медиків. Реанімація продовжується до відновлення самостійного дихання, прибуття бригади екстреної допомоги або повного фізичного виснаження рятувальника.

Окремим станом, що потребує уваги, є непритомність без зупинки серця. Якщо потерпілий не реагує на зовнішні подразники, але дихає самостійно, його необхідно перевести у стабільне бокове положення (відновлювальне положення). Це дозволяє запобігти западанню язика та асфіксії від блювотних мас, що є частою причиною смерті при втраті свідомості. Рятувальник повинен постійно контролювати наявність дихання до моменту прибуття лікарів. У випадках, коли причиною критичного стану став вплив зовнішнього фізичного фактора, алгоритм допомоги може доповнюватися специфічними діями. Особливо складним та небезпечним сценарієм є випадок, коли зупинка дихання та серця спровокована проходженням через тіло електричного струму, що вимагає специфічного підходу до безпеки та подальшої терапії уражених тканин.

Підсумовуючи, слід зазначити, що ефективна система надання домедичної допомоги на підприємствах є не лише нормативною вимогою, а й критичним елементом культури безпеки праці. Законодавча база, зокрема стаття 18 Закону

					<i>Дипломна робота</i>	Арк.
Зміни	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

України «Про охорону праці» та стаття 153 КЗпП України, покладає на роботодавця відповідальність за навчання персоналу, що є базовою умовою для мінімізації виробничого травматизму.

Практичне значення дотримання наведених протоколів полягає у переході від пасивного дотримання інструкцій до свідомої готовності працівників діяти в екстрених ситуаціях. Чітка послідовність дій — від оцінки ризиків та виклику екстрених служб до проведення реанімаційних заходів — дозволяє виграти час, який часто є визначальним фактором у боротьбі за життя. Таким чином, системна підготовка персоналу, регулярне оновлення знань згідно з актуальними наказами МОЗ України та розуміння юридичної відповідальності формують надійний фундамент для запобігання незворотним наслідкам нещасних випадків на виробництві.

					<i>Дипломна робота</i>	Арк.
Зміни	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		